

藥局供應 ECP 評估與轉介流程表（2026-08-03 更新版）

藥局辨識民眾是否可購買緊急事後避孕藥

（Emergency Contraceptive Pill, ECP）之評估與轉介流程表

本版為 2026-08-03 更新版（原版：01_藥局供應 ECP 評估與轉介流程表.md，2026-07-18 修訂，保留未動）。更新依據：2026-08-03 台灣婦產科醫學會張維君理事長、黃建霈秘書長對議題 1-5 之回應（詳《0803 婦產科醫學會對於 5 議題之回應_會議紀錄》）+ 第 3 場專家會議決議（2026-07-08）+ 日本「懷孕可能性判斷流程」與「緊急事後避孕藥銷售核對表」+ 國際指引（FSRH / ACOG / WHO）。試辦藥品以 LNG（Levonorgestrel）為限。

本次變更摘要：● 議題 1-5 全數獲醫學會回應，原 ● 標記依回應改為定案或維持；另新增制度定位說明與轉介未就醫者之追蹤要求。

議題	原標示	本版處理
1 血栓 / 子宮外孕病史 / PID	● 待確認	✓ 三者均可供藥；血栓須加強提醒、子宮外孕病史強調追蹤、PID 加強雙重避孕衛教
2 疑似懷孕 / 不願驗孕	● 不供藥	✓ 不願驗孕改 ● 供藥 + 告知 + 追蹤；已確診懷孕維持不給藥
3 異常陰道出血	● （建議改 ●）	✓ 維持 ● 不供藥、轉介（醫學會不採改 ● 之建

議題	原標示	本版處理
4 體重 / BMI	● 待確認	議) ✓ 問卷選填收集，未填不得拒絕供藥
5 嘔吐補服	● 待確認	✓ 設快速通道（24 小時內、自費）+ 併同提供轉介婦產科之選擇
流程分兩階段：階段一・線上評估（民眾自行上網填寫，於填問卷過程即完成篩選——命中禁忌或須就醫者線上導引就醫、不產生條碼、不必到藥局白跑）→ 階段二・到局現場（本人持 QR Code 到試辦藥局，身分核對後現場評估、供藥）。 三種處置結果：● 不供藥、直接轉介（婦產科 / 醫療院所）● 先供藥 + 衛教 + 轉介或通報（以預防懷孕為第一優先）● 可供藥（完成衛教後交付） ✓ 「醫學會已定案」＝經 2026-08-03 婦產科醫學會回應確認之項目。● 「提第 5 場」＝仍待後續場次確認之項目。🔗 各項處理建議之理由不在本表贅述；詳《第 4 場_流程表待拍板清單》對應議題。		

○、制度定位（2026-08-03 醫學會提醒，新增）

藥局供藥係「來不及就醫或無法就醫者之替代方案」，非優先途徑。最佳做法仍為由婦產科醫師評估——若民眾來得及就醫，應鼓勵其就醫評估。流程設計與衛教文字不宜使民眾形成「先到藥局、不得已才看婦產科」之順序認知。本節文字應併入衛教單張與線上評估表首頁說明。〔醫學會 2026-08-03〕

一、流程總覽

📄 完整流程圖請見審議平台「藥局判斷流程圖」頁面：

<https://yilingwork.github.io/ecp-trial-scheme/flowchart.html>（瀏覽器開啟即可檢

視、可列印) ——含檢核步驟+結果框、階段一線上 / 階段二藥局分區、醫療與社政轉介分開、 醫學會已定案之標註。

本檔以下各節(二~九)為流程圖各步驟之詳細判斷準則、衛教清單與依據；流程圖與本檔為同一套內容之兩種呈現，以 HTML 圖為單一視覺來源。

階段一・線上評估（民眾自行上網填寫，尚未到藥局）

於填問卷過程逐步篩選；命中任一  者，系統線上告知就醫、不產生購藥條碼。
順序：禁忌 → 懷孕 → 出血 → 時效。

二、 禁忌檢核（仿單禁忌，任一「是」即 不給藥）

詢問 / 判斷方		
# 檢核項目	式	處置
1 對 LNG 成分過敏	詢問過敏史	 轉介（本試辦僅 LNG、無替代品項）
2 嚴重肝功能障礙	依國內仿單禁忌詢問病史	 轉介（禁忌症）。「嚴重肝功能障礙」指肝硬化、肝衰竭、黃疸、腹水；B 肝帶原、輕度肝功能異常、脂肪肝不屬此列、可正常給藥

非禁忌、正常給藥（勿誤擋）：血栓病史（VTE）、子宮外孕病史、骨盆腔發炎（PID）均非 LNG 禁忌，正常供藥；子宮外孕僅「疑似急性現症」才轉介。
〔議題 1・醫學會已定案〕

2-1 議題 1 三項病史之處置細則 (2026-08-03 醫學會定案)

病史	供藥與否	應加強之衛教 / 提醒
血栓病史 (VTE)	✅ 可供藥	用藥要比較小心、須特別提醒民眾。雖實際發生血栓者極少（「十萬個人才十多個」），但發生過的人若沒好好控制，再發率高很多倍（雖不見得與使用黃體素有關）。〔醫學會〕
子宮外孕病史	✅ 可供藥	曾發生者再次子宮外孕比例較高 → 務必提醒本人一定要回診追蹤；不追蹤者風險顯著較高。強化子宮外孕警訊衛教（單側下腹劇痛、異常出血即就醫）。〔醫學會〕
骨盆腔發炎 (PID) 病史	✅ 可供藥	此類個案常因反覆無防護性行為而反覆感染（PID 亦屬性傳染病之一）→ 加強「保險套 + 常規避孕藥」雙重避孕衛教與性病防治衛教。〔醫學會〕

⚠️ 唯一例外——疑似急性子宮外孕現症（單側下腹劇痛 + 面色蒼白 + 冒冷汗）
→ 🚑 逕送有婦產科之急診。此非用藥禁忌，而係病人本身為救命外科急症。

📎 仿單查證附註（血栓）：國內 LNG 仿單對血栓之記載因含量規格而異。已查核 13 張現行有效許可證仿單：2 張 0.75 毫克品項（046441「培力」愉婷錠、027418 韻急停錠）均載有血栓警語，列於【特殊警告及使用上注意事項】、非禁忌症，處置為「需小心觀察，評估利弊比率後使用」；11 張 1.5 毫克品項均

無血栓警語，且藥效學段落明載「在使用劑量下，Levonorgestrel 不會顯著改變凝血因子」。引用仿單時應指明品項，不宜泛稱「國內仿單有提醒」。詳《查證_國內 LNG 仿單血栓注意事項》。

三、② 懷孕可能性評估（依日本核對表，含「3 週驗孕」判準）

 本步驟還原第 3 場所參照之日本核對表並補「3 週驗孕」判準（僅「有懷孕徵兆+3 週前曾無防護性行為」之窄族群才需驗孕，其餘不需驗孕即可給藥）。設計理由詳議題 2。

步驟	詢問 / 判斷方式	處置
① 徵兆	是否有懷孕徵兆（週期不規則 / 末次月經已逾週期 / 末次月經不確定〔經量少、週期短〕 / 產後流產後月經未恢復）？	無徵兆 → 續問 ③ （不需驗孕）；有徵兆 → 續下
② 3 週驗孕	有徵兆者再問：距今「3 週以前」是否曾有無防護性行為？	否（僅近 3 週內發生）→ 不需驗孕、可給藥（服用前追加「不排除本次之前懷孕之可能」說明）；是 → 續下（驗孕）
③ 驗孕結果	3 週前曾有性行為者 → 建議使用驗孕棒	陽性（已確診懷孕）→  不給藥、轉介婦產科 （本藥懷孕用藥分級屬 X 級，已確定懷孕不應使用；並確認懷孕位置、排除子宮外孕、產檢）陰性 → 續問 ③ 不願驗孕 → 

步驟	詢問 / 判斷方式	處置
		供藥（不因不願驗孕而擋藥）＋下列告知與追蹤

3-1 不願驗孕者之處置（2026-08-03 醫學會定案，由 ● 改 ●）

不必因「不願驗孕」或「疑似懷孕」即擋藥，改以充分告知處理。〔醫學會〕

供藥時應完成之告知（納入個人化衛教清單）：

1. 若已確定懷孕，即不應服用本藥；本藥對已成立之懷孕無效，亦無法終止懷孕。
2. 若疑似懷孕，務必注意後續追蹤——可能於本次之前即已受孕而不自知（例如 5 天前曾有不安全性行為、未全程使用保險套），本次又有未保護之性行為而來服藥，惟其實已無效。
3. 月經未按預期時間到來，或出現亂經，應即找醫師。
4. 服藥後約 3 週建議驗孕或回診確認避孕成功。

⚠ 追蹤要求（醫學會特別提出）：本試辦及未來正式制度均無強制民眾就醫之權力，經建議轉介者仍可能不就醫。故必須記錄並追蹤「經建議轉介卻未就醫者」之後續情況，累積資料供未來政策參考。此追蹤機制與第 5 場（第 12、13 章）追蹤設計連動。

四、③ 異常陰道出血評估（兩問法）✔

步驟	詢問 / 判斷方式	處置
問①	最後一次月經什麼時候？	續下
問②	該次出血與平常月經有無不同（量、天數、顏色）？	續下
判定	不同、說不清楚、或當下正在出血且無法判斷是否為月經	● 維持不供藥、轉介婦產科查出血原因（排除子宮外孕、子宮內膜病變等，出血鑑別屬醫師專業）；合併疑

步驟	詢問 / 判斷方式	處置
		似子宮外孕急性徵象（單側劇痛、面色蒼白冒冷汗）→ 視為急診
判定	月經正常、無異常出血	續問 ④

✅〔議題 3・醫學會已定案〕維持 🚫 不供藥、直接轉介。醫學會明確表示不採「改 🟡 先給藥 + 當日轉介查因」之建議，理由為異常出血當中有部分情形服藥後會出問題。📎 附記：本項與國際指引（FSRH / ACOG「照常供藥 + 轉介排除外孕」）方向不同，係採較嚴格之把關，理由已記錄於會議紀錄。

五、④ 時效窗口（距最近一次未受保護性行為之時數）

時數	判定	處置
72 小時內	LNG 有效	通過線上篩選（時效題於到場當下再重算）
72–96 小時	LNG off-label、無可靠療效數據	🚫 維持轉介、不給藥（已定案・非議題）；72h 後效果未知（國內仿單：24h 95% / 48h 85% / 72h 58% / >72h 未知），逾時線上即導引就醫、不產生條碼
超過 96 小時	LNG 已無效	🚫 / 轉介婦產科評估 UPA（120 小時內） / 含銅子宮內避孕器（5 日內），口頭告知剩餘時數之急迫性

此為「效果」而非「安全」判斷準則。線上初篩逾 96h 即導引就醫、不產生條碼；72h 內者時效題仍須於到場當下重算（防填答與到場之時間差）。通過 ①—④ → 系統產生 QR Code（購藥條碼）+ 顯示附近可購藥之試辦藥局。

階段二・到局現場（本人持 QR Code 至試辦藥局）

六、⑤ 前置確認（到局身分核對）

#	檢核項目	詢問 / 判斷方式	處置
1	本人親領	掃碼調閱線上填答；核對 到場者 = 線上填答者 = 證件本人 （不可代購）	不符 → ● 不供藥
2	個資同意	確認線上已簽署個人資料提供同意書	不符 → ● 不供藥
3	時效重算	時效題以到場當下重算（時數、當下是否出血）；如已逾時或新增出血 → 回 ④ / ③ 對應處置	逾時 / 新增異常 → 依對應步驟

● **不供藥**：不符本人親領要件（代購 / 身分不符）者，本試辦不予供應；得依現行程序至醫療院所就醫取得。（核對相符、仍在時效內 → 續問 ⑥）

七、⑥ 需醫療 / 社政銜接檢核（● 先供藥 + 衛教 + 轉介 / 通報，以預防懷孕為第一優先）

#	檢核項目	處置
1	疑似性暴力 / 性侵害	先供藥；藥師為責任通報人員，依法 113 通報 （單一窗口），由社工介入並陪同至 具社工之醫院 （一站式服務）就醫採證；避免個案重複陳述
2	性傳染病風險（伴侶已知感染、新 / 陌生伴侶且無套、本人有症狀、多重性伴侶）	供藥 + 建議至婦產科接受性病篩檢
3	短期重複使用（如一個月內再次購買）	供藥（重複使用無嚴重安全疑慮，惟月經易紊亂） + 主動提供常規避孕衛教 + 轉介

#	檢核項目	處置
4	哺乳中	婦產科+納入追蹤 供藥+衛教。已查證國內 LNG 仿單無「暫停 24h」 → 依國際「可繼續哺乳」 (衛教：服藥前先哺乳、避免服後馬上哺乳；非議題)
5	服用肝酵素誘導劑（部分抗癲癇藥、聖約翰草等）	供藥+告知效果可能降低+詳細諮詢用藥 / 保健食品 (台灣得在同意+持健保卡下查雲端藥歷核對)。依國內仿單「效果可能降低、告知醫師 / 藥師」、不另設劑量調整；非議題
6	非通報之社會風險個案（脆弱家庭等）	供藥+於衛教單提供社福資源 QR Code，鼓勵自主聯繫 (不強制轉介、不追蹤)
7	體重過重 (>70kg / BMI>26) 	供藥（本試辦僅 LNG）+告知高 BMI 可能降低效果。體重資料於線上問卷「選填」收集，詳 7-1〔議題 4・醫學會已定案〕
8	血栓 / 子宮外孕病史 / PID 	供藥+依 2-1 表加強對應提醒與追蹤衛教〔議題 1・醫學會已定案〕
9	不願驗孕（階段一帶入） 	供藥+依 3-1 完成四項告知+納入未就醫追蹤〔議題 2・醫學會已定案〕

皆「否」→ ● 給藥＋一般衛教。

7-1 體重資料收集方式（2026-08-03 醫學會定案）

1. 可以收集，但列為「選填」（option）——體重過重會使效果較差，資料可收集並供後續追蹤分析。
2. 不得因未填而拒絕供藥——醫學會明確表示「沒有說不填就不能給藥，沒有到這樣」。
3. 理由：部分女性對體重敏感、不願填寫；若因未填而拿不到藥並不妥當，婦女團體亦不易接受強制填寫。
4. 有填答且 $>70\text{kg}$ / $\text{BMI}>26$ 者 → 於個人化衛教清單加掛「效果可能降低」之告知。

八、● 可供藥：標準衛教項目（系統依填答自動帶出個人化清單，藥師逐項確認）

1. 盡速服用（越早效果越好）；不強制當場服用（願意者可當場服）。
2. 服藥後短時間內（2—3 小時）嘔吐須補服。✔【議題 5·醫學會已定案】嘔吐補服快速通道詳 8-1。
3. 常見副作用：月經提前 / 延後、點狀出血、噁心、頭痛。
4. 警訊衛教：月經延遲逾 1 週應驗孕；服藥後約 3 週建議驗孕或回診確認避孕成功；出現下腹劇痛或異常出血應立即就醫（子宮外孕警訊，發生率約萬分之一，惟延誤危險）。
5. ECP 為補救措施、非常規避孕；提供常規避孕與雙重避孕衛教及銜接方式。依醫學會提醒，明確告知「真正妥適的避孕方式是保險套＋常規避孕藥之雙重避孕」。
6. 衛教單附社福資源與相關諮詢 QR Code。
7. 依○、制度定位，告知「來得及就醫者仍建議由婦產科醫師評估」。
8. 藥師於系統逐項確認衛教完成 → 完成給藥紀錄、結案（防跨店重複購買）。

8-1 嘔吐補服快速通道（2026-08-03 醫學會定案）

醫學會原則不反對設置，惟須符合下列條件：

項目	規則
時間限定	24 小時內憑原條碼 / 原給藥紀錄回店
費用	須再收取一次費用（本項本即自費項目）
系統處理	藥師確認情節後以「補服代碼」記錄、免重新評估、不計入短期重複使用、跨店適用
併同提供轉介婦產科之選擇	嘔吐補服或建議轉介婦產科，提供補服之外的另一種選擇；補服流程須同時提供另一條就醫管道

轉介理由（醫學會說明）：

1. 若嘔吐係藥物本身引起，再服一劑很可能再次嘔吐、甚至更嚴重（連續兩次劑量累積更高）。
2. 若嘔吐係其他原因引起，待狀況改善後再服或許無虞——惟須由醫師判斷。
3. 婦產科端可一併處理嘔吐問題，並告知其他可行的避孕方式（不必然只能服用緊急避孕藥）。

各情境對應之個人化衛教清單（系統依填答自動帶出）

「基礎清單」= 上列 1-7 項。系統依線上填答與現場評估結果，於基礎清單上自動加掛該情境之加值衛教項目（連動資訊系統功能 B-6「個人化衛教清單」）。

情境（處置結果）	衛教清單內容
● 一般供藥	基礎清單 1-7（全員必做）
● 疑似性暴力 / 性侵害 (6-1)	基礎清單 + 113 通報與一站式服務流程說明（就醫會經歷什麼、社工陪同）+ 保留證據提醒 + 心理支持資源
● 性傳染病風險 (6-2)	基礎清單 + 性病篩檢衛教（建議婦產科篩檢項目、windows period 概念）+ 保險套正確使用

情境（處置結果）	衛教清單內容
● 短期重複使用 (⑥-3)	基礎清單 + 強化常規避孕衛教 (LARC 等選項比較、轉介婦產科避孕諮詢) + 月經紊亂預期說明 + 追蹤說明
● 哺乳中 (⑥-4)	基礎清單 + 哺乳衛教 (已查證國內仿單無「暫停 24h」→ 依國際「可繼續哺乳」；衛教服藥前先哺乳、避免服後馬上哺乳)
● 服用肝酵素誘導劑 (⑥-5)	基礎清單 + 交互作用衛教 (效果可能下降之告知、後續避孕加強措施)
● 非通報之社會風險個案 (⑥-6)	基礎清單 + 社福資源引導強化 (QR Code 內容逐項說明、鼓勵自主聯繫)
● 體重過重 (⑥-7, 僅有填答者)	基礎清單 + 效果可能降低之告知
● 血栓病史 (⑥-8) ✓	基礎清單 + 血栓相關提醒 (醫學會：用藥須較小心、應特別提醒)
● 子宮外孕病史 (⑥-8) ✓	基礎清單 + 強化子宮外孕警訊衛教 + 「務必回診追蹤」之明確叮嚀
● PID 病史 (⑥-8) ✓	基礎清單 + 強化雙重避孕衛教 (保險套 + 常規避孕藥) + 性病防治衛教
● 不願驗孕 (⑥-9) ✓	基礎清單 + 3-1 之四項告知 (已確診懷孕不應服用、疑似懷孕務必追蹤、亂經或月經延遲應就醫、3 週驗孕) + 納入未就醫追蹤
● 嘔吐補服 (8-1) ✓	基礎清單 + 轉介婦產科之選擇說明 (再服可能再吐、可一併處理嘔吐、可討論其他避孕方式)
● 不供藥、直接轉介	無供藥衛教；改為就醫指引 (轉介事由說明、就醫時效急迫性〔UPA≤120h / 含銅 IUD≤5 日〕、就醫會經歷什麼) + 轉介單

情境（處置結果）	衛教清單內容
● 不符本人親領	+ 納入未就醫追蹤 替代途徑告知（現行就醫程序、時效急迫性）+ 記錄已告知時間

九、依據與待確認事項

9-1 已定案項目（2026-08-03 醫學會回應）

議題 1–5 全數獲回應並定案，處置分別載於 2-1、3-1、四、7-1、8-1 各節。另新增：

1. **制度定位（○節）**：藥局供藥為就醫不及之替代方案。
2. **未就醫者追蹤（3-1）**：須記錄並追蹤經建議轉介卻未就醫者之後續情況。
3. **雙重避孕衛教（八-5）**：明確告知保險套 + 常規避孕藥為妥適避孕方式。

9-2 嚴重肝功能障礙之定義（補充）

1. **婦產科臨床實務判準**：肝功能指數（GOT / GPT）達正常值兩倍以上即須小心。⚠️
正常值上限依各檢驗室標準略有不同，引用時應查證正式參考值。
2. **「嚴重到何種程度不得服用」須由腸胃肝膽科界定**——醫學會建議此定義詢問腸胃肝膽科較為正式（非婦產科專業範圍）。待洽腸胃肝膽科專家確認。
3. **判斷時應權衡：胃肝功能風險 vs. 未避孕之風險**，並考量該個案未必只能使用緊急避孕藥——婦產科端可提供其他避孕方式解決其需求。

9-3 仍待後續確認事項

- **未成年（兒少）之供藥條件與家長同意**——第 4 場（第 8 章）討論後補入（未滿 16 歲之通報屬現行法，須先於流程加年齡節點）。
- **追蹤機制（第 21 天追蹤、追蹤方式）**——第 5 場（第 12、13 章）討論後補入；須併同納入 3-1「經建議轉介卻未就醫者」之追蹤設計。
- **性暴力個案之法定通報管道與 113 之關係、24 小時時限、轉介操作**——已規劃函詢衛福部保護司。函詢時點：俟第 4 場會議確認所有轉介情境後再一併函詢。

- 嚴重肝功能障礙之量化定義——待洽腸胃肝膽科（見 9-2）。
- ⚠ 禁忌欄依品項而異之影響：已查核之 13 張國內 LNG 仿單中，多數（11 張）禁忌欄僅列「成分過敏」，但衛部藥輸字第 027979 號（韻急停錠 1.5 毫克）另列「嚴重肝機能不全」與「懷孕」為禁忌，027418 號亦將「已懷孕」列入禁忌欄。故「LNG 唯一絕對禁忌 = 成分過敏」之陳述須說明各廠仿單不一致，或限定於特定品項。此點影響 ❶ 禁忌檢核與議題 2 之論述基礎，建議提請專家會議確認試辦指定品項後據以定稿。詳《查證_國內 LNG 仿單血栓注意事項》。

9-4 原有依據

- 國際指引（FSRH / ACOG / WHO）原則：供應 ECP 前不需內診或驗孕、不得因體重 / 肥胖拒絕供應；本流程之驗孕關卡係採日本模式（僅於懷孕可能性存疑時實施），設計理由為「防誤判、即時轉介」而非安全風險。
- 各項之國際實證與改動理由，詳《第 4 場_流程表待拍板清單》議題 1—5 / 非議題項及附錄（國際實證依據）。